

吞咽康复训练在不随意运动型脑瘫儿童中的应用效果

张 丽 张 怡

(连云港市社会福利中心, 江苏 连云港 223300)

【摘要】目的: 分析研究在不随意运动型脑瘫儿童护理中应用吞咽康复训练的临床效果。方法: 抽取2018年1月至2023年12月于连云港市社会福利中心儿童部治疗的100例不随意运动型脑瘫患儿, 抽签划分为对照组与研究组, 各50例。对照组行常规护理, 研究组行吞咽康复训练, 以护理有效性、吞咽功能、流涎程度与保育员满意度为依据比较两组患儿护理效果。结果: 研究组患儿护理有效性与保育员满意度明显高于对照组, 且研究组患儿吞咽障碍评分低于对照组, 流涎等级Ⅰ级, Ⅱ级占比均明显高于对照组, Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级占比均低于对照组, 差异显著 ($P < 0.05$)。结论: 在不随意运动型脑瘫患儿护理中应用吞咽康复训练, 能够有效改善患儿吞咽障碍与流涎情况, 从而提升其护理干预效果, 得到患儿保育员更高的满意评价, 应用效果显著。

【关键词】 吞咽康复训练 不随意运动脑瘫 小儿脑瘫 流涎

DOI:10.20255/j.cnki.issn1674-9561.2024.19.032

小儿脑瘫属于神经系统病症, 是持续性存在的姿势发育障碍与中枢运动障碍, 主要由患儿在发育过程中中枢神经系统受损导致, 在临床上较为常见。按瘫痪部位进行划分, 脑瘫可分为三肢瘫、四肢瘫、双瘫与单瘫; 以运动障碍为依据, 可分为混合型临床分型、肌张力低下型、痉挛型及不随意运动型。其中最常见的分型为不随意运动型, 患儿活动受限, 基底节部位受损, 吞咽肌群的稳定性与张力受损, 导致其出现吞咽障碍, 且口腔敏感度较低, 难以闭合口唇, 发生咀嚼困难、不协调等情况^[1, 2]。长期存在的吞咽障碍会导致患儿因进食障碍而出现营养不良, 还易引发误吸性肺炎等。因此, 应给予患儿有效的护理干预, 通过吞咽功能训练来改善患儿吞咽能力, 提高其营养水平, 提升其生存质量^[3]。基于此, 本研究探究不随意运动型脑瘫儿童护理中应用吞咽康复训练的临床效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究以不随意运动型脑瘫患儿为研究样本, 从2018年1月至2023年12月连云港市社会福利中心儿童部治疗的患儿中抽取100例, 抽签划分为对照组与研究组, 各50例。

对照组患儿男女比例为26:24, 年龄为4个月至18岁, 平均 (8.92 ± 1.47) 岁, 体重3.3~11.4 kg, 平均 (6.81 ± 0.54) kg。研究组患儿男女比例为26:24, 年龄为5个月至18岁, 平均 (8.84 ± 1.26) 岁, 体重3.4~11.2 kg, 平均 (6.54 ± 0.76) kg。两组患儿性别、年龄等基线资料比较, 无显著差异 ($P > 0.05$)。研究内容经医院伦理委员会批准, 且患者及其保育员对研究知情。

1.2 纳入标准和排除标准

纳入标准: ①患儿经颅脑CT检查, 符合《中国脑性瘫痪康复指南(2022年)》中相关诊断标准, 确诊为不随意运动型小儿脑瘫。②伴有不同程度喂养困难、吞咽障碍及流涎情况。③临床基线资料完整。

排除标准: ①伴有凝血功能障碍、免疫系统障碍。②合并传染性疾病。③合并严重器官功能缺损。④合并咽喉、口腔畸形。⑤合并其他类型行为异常。

1.3 方法

对照组患儿给予常规康复护理。以吞咽语言刺激治疗仪进行干预, 并提供语言疗法、运动训练等康复干预。

观察组患儿在使用吞咽语言刺激治疗仪30 min后接受吞咽康复训练。主要有以下几点: ①流涎康复训练。训练患儿进行亲吻、微笑、鼓腮等动作, 以加强口唇协

调能力、提升唇部力量，可使用冰块对舌头与口咽部进行刺激，促进其分泌唾液；在患儿牙齿与嘴唇间放置拴线纽扣，间断式手拉提线，以训练患儿口唇闭合能力，并通过吞咽唾液训练加强患儿吞咽能力，注意避免发生误咽情况。②摄食干预。调整患儿姿势与体位，以适宜进食并保证其能够顺利完成复杂的吞咽活动，且应注意调节患儿躯干应力与头部制动力，稳妥固定其肩、脚位置，注意不可仰卧位进食。若患儿能够自主进食，应以坐位进食为主；若患儿年龄较小，可抱坐喂食，且结束喂食后应在其背部轻拍，以帮助患儿将胃内空气排出，从而避免食物外溢情况发生。在饮食选择方面，应以温性饮食为主，且遵循由少至多的原则为患儿喂食，喂食量可逐渐增加，过程中尽量直接将食物送到患儿的舌头中后位置，并对舌体进行轻压，以刺激其咬合反射，注意提醒患儿缓慢进食。注意在喂食期间需观察其表情变化，其应在完全吞咽结束，才可进行下一次喂食，严禁强行喂食，且餐具应根据吞咽障碍程度选择。③吸吮功能训练。应观察患儿吸吮能力并进行评估，以此为依据进行功能训练计划制订。对于年龄较小的患儿，可以引导其吸吮自身手指，同时辅助进行咬肌按摩，以提升吸吮力度；对于年龄较大的患儿，可提供果汁练习吸吮，注意引导患儿逐步开展训练，以实现自主使用吸管食用流食或奶瓶吸奶的目的。④咀嚼功能训练。应根据患儿生长发育的规律，循序渐进地进行舌碾期训练，通过口腔敏感性训练等提升唇齿咬合能力。⑤口腔功能训练。进行口腔训练操与棉签蘸液试验，以提升患儿吞咽肌群敏感度及对味道和食物的敏感性，促进患儿恢复吞咽功能。

两组患儿均进行3个月康复护理，每月进行1次吞咽功能与流涎分级评估，并以此为依据调整康复训练计划。

1.4 观察指标

(1) 对比两组患儿护理有效率，包括显效、有效及无效。显效：患者能够自主吞咽，流涎情况有大幅度改善；有效：患者吞咽能力有明显提升，但仍需保育员辅助，流涎情况减轻；无效：患者吞咽障碍与流涎情况无改善，需保育员时刻照顾。显效率与有效率之和为总有效率。

(2) 对比两组患儿吞咽功能。以吞咽困难调查量表(DDS)进行评估，判断患儿在进食硬质食物、软质食物及流食过程中的吞咽问题，包括口腔期(15分)、咽期(6分)及食管期(3分)，吞咽问题越严重则分数越高。

(3) 对比两组患儿吞咽训练后流涎等级。以教师分级法进行评估，包括Ⅰ～Ⅴ级。不流涎为Ⅰ级；偶尔小量流涎为Ⅱ级；有时流涎为Ⅲ级；经常流涎为Ⅳ级；胸前常弄湿，成线流涎为Ⅴ级。

(4) 对比两组患儿保育员对康复护理的满意度。自拟满意度调查表，请保育员对康复训练效果、护理态度等进行评价，记为0～100分，>80分表明保育员非常满意，60～80分表示其比较满意，<60分表示其不满意。比较满意率与非常满意率之和为总满意率。

1.5 统计学方法

本研究数据使用SPSS 22.0统计学软件进行分析，计数资料以 $n(\%)$ 表示，行 χ^2 检验；计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，行 t 检验。 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组护理有效率对比

研究组患儿护理有效率明显高于对照组，差异具有统计学意义($P < 0.05$)，见表1。

表1 两组患儿护理有效率对比 [$n(\%)$]					
组别	n	显效	有效	无效	总有效率
研究组	50	28 (56.00)	19 (38.00)	3 (6.00)	47 (94.00)
对照组	50	22 (44.00)	18 (36.00)	10 (20.00)	40 (80.00)
χ^2					4.332
P					0.037

2.2 两组吞咽功能对比

研究组患儿吞咽障碍评分明显低于对照组，差异具有统计学意义($P < 0.05$)，见表2。

2.3 两组流涎等级对比

研究组患儿流涎等级Ⅰ级、Ⅱ级占比均明显高于对照组，Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级占比均明显低于对照组，两组差异具有统计学意义($P < 0.05$)，见表3。

表2 两组患儿吞咽功能对比 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	n	口腔期		咽期		食管期	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
研究组	50	10.77 ± 1.34	6.47 ± 1.44	4.53 ± 0.66	2.67 ± 0.62	2.17 ± 0.52	1.27 ± 0.43
对照组	50	10.87 ± 1.29	8.39 ± 0.95	4.61 ± 0.58	3.71 ± 0.45	2.32 ± 0.42	1.95 ± 0.22
t		0.380	7.870	0.644	9.599	1.587	9.955
P		0.705	<0.001	0.521	<0.001	0.116	<0.001

表3 两组患儿流涎等级对比 [n (%)]

组别	n	I 级	II 级	III 级	IV 级	V 级
研究组	50	15 (30.00)	25 (50.00)	10 (20.00)	0 (0)	0 (0)
对照组	50	6 (12.00)	12 (24.00)	27 (54.00)	5 (10.00)	0 (0)
χ^2		4.883	7.696	12.398	5.263	<0.001
P		0.027	0.006	<0.001	0.022	<0.001

2.4 两组满意度对比

研究组患儿保育员对护理服务的满意度比对照组更高，差异具有统计学意义 ($P<0.05$)，见表4。

表4 两组满意度对比 [n (%)]

组别	n	非常满意	比较满意	不满意	总满意率
研究组	50	27 (54.00)	21 (42.00)	2 (4.00)	48 (96.00)
对照组	50	22 (44.00)	20 (40.00)	8 (16.00)	42 (84.00)
χ^2					4.000
P					0.046

3 讨论

不随意运动型脑瘫患儿咽喉、口唇及舌部肌群有明显的协调情况，流涎、吞咽与咀嚼困难是其常见表现，且由于患儿长时间难以运动而容易出现肌肉力量不足、肌肉紧张、肌张力过高情况，在机体能力的持续消耗下，极易出现营养不良、负氮失衡情况 [4, 5]。由于大部分脑瘫患儿唾液分泌旺盛，口腔控制力不足，故流涎情况严重，需对患儿进行有效的口腔功能训练。吞咽语言刺激治疗仪对患儿吞咽系统功能有电刺激作用，能够提升患儿吞咽肌群的能力，在使用治疗仪的同时，还需对患儿进行康复干预，以切实提升相关肌肉功能 [6, 7]。目前，不随意运动型脑瘫患儿的吞咽功能改善是医学研究的热点问题，脑瘫患儿肌肉力量与运动功能的提升是其康复训练的重难点。吞咽康复训练对患儿吞咽功能有显著改善效果，其根据患儿流涎与吞咽困难程度，对患儿不同时期进行针对性功能训练，为患儿提供准确的康复干预 [8, 9]。

从本研究可知，应用吞咽康复训练的患儿，流涎等级 I 级、II 级占比均明显高于对照组，III 级、IV 级、V 级占比均低于对照组 ($P<0.05$)，表明吞咽康复训练能有效提升患儿流涎等级，减少流涎。这是由于吞咽康复训练能给予患儿专业的流涎干预、摄食能力干预、吸吮与咀嚼能力干预及口腔功能训练，能够有效改善患儿吞咽障碍，为患儿提供不同部位的针对性训练，从而可有效降低患儿口腔敏感度，改善其吸吮与咀嚼难的情况，减少流涎，

提升患儿身体状态。此外，进行吞咽康复训练的患儿口腔期吞咽障碍分数为 (6.47 ± 1.44) 分，咽期吞咽障碍分数为 (2.67 ± 0.62) 分，食管期吞咽障碍分数为 (1.27 ± 0.43) 分，均显著低于常规护理患儿 ($P<0.05$)，说明其能够有效改善吞咽障碍，提升患儿吞咽能力。这是由于吞咽康复训练以康复训练理论为基础，对患儿吞咽障碍情况进行多维度研究，在对患儿身体功能进行准确评估后，为其制订行之有效的康复干预计划，明确训练目标，指导患儿进行康复训练并定期评估、调整，并不断完善吞咽能力训练计划，故可有效提升患儿吞咽的能力，减少误吸情况 [10]。

综上，将吞咽康复训练应用于不随意运动型脑瘫患儿护理中的效果显著，其可有效改善患儿吞咽障碍与流涎情况，治疗有效性较高，患儿保育员对康复护理效果较为满意，可进行推广使用。

【参考文献】

[1] 朱登纳, 乔璐莎, 张广宇, 等. 儿童不随意运动型脑性瘫痪肌张力障碍的研究进展 [J]. 中国实用儿科杂志, 2023, 38 (1) : 26-30.

[2] 李文娟. 吞咽康复护理在不随意运动型脑瘫儿童中的应用价值 [J]. 中外医药研究, 2023, 2 (5) : 84-86.

[3] 刘盈, 赵晶, 孙光, 等. 吞咽康复护理技术在不随意运动脑瘫儿童中的应用 [J]. 黑龙江医药科学, 2022, 45 (4) : 94-96, 98.

[4] 李小妍. 吞咽康复护理技术在不随意运动脑瘫儿童中的应用 [J]. 健康之友, 2022 (23) : 191-193.

[5] 郑日双, 曾丽玉. 神经运动发育程序指导下的进阶性康复训练对脑瘫患儿BBS评分及运动功能的影响 [J]. 医学理论与实践, 2024, 37 (1) : 161-163.

[6] 陈潇, 梁丽清, 林雪儿, 等. Bobath护理对6~14周岁不随意运动型脑瘫患儿进食功能、神经功能及日常生活能力的影响 [J]. 国际护理学杂志, 2023, 42 (24) : 4504-4508.

[7] 李维佳, 林琳, 刘芳, 等. 中医综合康复护理结合功能训练对脑瘫患儿运动功能和智力发育的影响 [J]. 临床医学工程, 2023, 30 (10) : 1453-1454.

[8] 朱颖华. 个性化康复护理配合捏脊、足部护理对脑瘫患儿运动功能及日常生活能力的影响 [J]. 黔南民族医专学报, 2023, 36 (3) : 212-215.

[9] 史勇妮. 小儿脑性瘫痪患者的护理和支持 [J]. 青春健康, 2023, 21 (16) : 40-41.

[10] 芦静, 董婵, 许令, 等. 呼吸肌训练及ICF-CY理论下康复护理在脑瘫患儿中的应用 [J]. 齐鲁护理杂志, 2023, 29 (15) : 85-88.